

Kiedy OCPD i OCD *idą w parze*

U części osób oba zaburzenia występują naraz i wzajemnie się napędzają. Rozumienie tego splotu pomaga zaplanować terapię tak, by działała na obie warstwy.

CZAS: 12 min Karta orientacyjna **ŹRÓDŁO:** DSM-5-TR (APA, 2022); badania nad współchorobowością

JAK UŻYWAĆ

Ta karta wyjaśnia, co się dzieje, gdy **osobowość anankastyczna (OCPD)** i **zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)** współwystępują — jak się wzajemnie wzmacniają i co to oznacza dla terapii. Na końcu przygotujesz pytania do specjalisty. To karta orientacyjna; plan leczenia ustala się indywidualnie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Gdy oba zaburzenia występują razem, perfekcjonizm i potrzeba kontroli z OCPD **zasilają** natręctwa OCD: wysoki standard sprawia, że rytuały „muszą być” wykonane idealnie, a nietolerancja niepewności podsyca lęk. Z kolei OCD wzmacnia sztywność. Powstaje błędne koło. Świadomość tego splotu pomaga dobrać **kolejność i akcenty** terapii — i nie zniechęcać się, gdy praca jest bardziej złożona.

01 → Jak się wzajemnie napędzają

Cechy OCPD i objawy OCD potrafią tworzyć samonapędzającą się pętlę:



02 ☉ Co to znaczy dla terapii

Często najpierw OCD — ekspozycja z powstrzymaniem reakcji zwykle adresowana jest na początku, bo objawy najbardziej dokuczają.

Równolegle praca nad sztywnością — bo perfekcjonizm OCPD podtrzymuje rytuały i utrudnia ekspozycję.

Tolerancja niepewności — wspólny rdzeń obu; ćwicz się ją w jednym i drugim obszarze.

Większa cierpliwość — dwie warstwy to dłuższa praca; potknięcia są naturalne.

Na co zwrócić uwagę

Gdy oba zaburzenia idą w parze, łatwo pomylić ich objawy lub zniechęcić się tempem. Pomocne wskazówki:

Rozróżniaj „chęć” od „muszę”. Pomaga rozpoznać, co jest cechą stylu (OCPD), a co przymusem redukującym lęk (OCD) — i właściwie to adresować.

Nie wymagaj idealnej terapii. Perfekcjonizm potrafi przenieść się na samo leczenie („muszę robić zadania bezbłędnie”) — to też warto nazwać.

Mierz postęp łagodnie. Spadek częstości rytuałów i większa elastyczność to sukcesy — nawet bez całkowitego ustąpienia objawów.



Moje pytania do terapeuty

Zapisz, co chcesz omówić, jeśli podejrzewasz u siebie oba wzorce.

PYTANIA I OBSERWACJE NA SESJĘ

— co mnie niepokoi, co zauważam

Klucz: współwystępowanie OCPD i OCD nie oznacza, że „jest gorzej” — oznacza, że terapia musi działać na dwóch poziomach jednocześnie: na konkretne natręctwa i na sztywny styl, który je podtrzymuje. Wspólnym mianownikiem obu jest trudność z tolerowaniem niepewności i niedoskonałości. Praca nad tym rdzeniem przynosi ulgę w obu obszarach naraz. To zadanie dla terapii prowadzonej przez specjalistę.